

Trauma torácico · pneumotórax e ameaças

No trauma torácico, as ameaças imediatas ao B são pneumotórax hipertensivo, aberto e tórax instável/contusão. Diagnóstico clínico no instável — não atrase descompressão por Rx.

PNT simples

Dica - PNT simples

Pode ser olhido no primário se estável. Confirme com Rx/USG (e-FAST) e drene conforme tamanho/sintoma/ ventilação mecânica — PNT + VPM tem alto risco de hipertensão.

Triagem ATLS: hipertensivo !' agulha/dreno; aberto !' curativo 3 pontas + dreno; hemotórax massivo !' dreno + sangue/cirurgia.

Ameaças torácicas ao B

Hipertensivo / aberto / hemotorax massivo

PNT hipertensivo

Distress + desvio traqueal
MV abolido / turgencia
Descompressao imediata

Emergencia clinica

PNT aberto

Ferida sugadora
Curativo 3 pontas
Toracostomia

Nao ocluir 4 lados

Hemotorax massivo

>1500 mL ou debito alto
Dreno + reanimacao
Toracotomia se indicado

Choque + torax

Pontos de prova

- Descompressão: agulha no 2º EIC linha hemiclavicular ou 5º EIC axilar anterior, seguida de dreno
- Dreno torácico: 4º/5º EIC linha axilar média (triângulo de segurança)
- Tórax instável: O., analgesia, VPM se insuficiência; fixação cirúrgica selecionada
- Tamponamento: choque + jugulares + bulhas abafadas !' pericardiocentese/janela

Achados clínicos

Lesão | Clínica-chave

PNT hipertensivo | Hipotensão + MV! + desvio contralateral

PNT aberto | Ferida torácica com bolhas/som

Hemotórax | Macicez + choque + MV! +

Contusão pulmonar | Hipoxemia progressiva pós-trauma

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Pneumotórax hipertensivo é diagnóstico clínico. Não leve o instável ao Rx 'para confirmar' antes de descomprimir.